

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL
DE HUAMANGA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**



**PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE
CUALITATIVO**

**Percepción de la Calidad de Atención en Usuarios del Centro de
Salud Belén, Ayacucho 2026**

Para optar el título profesional de:
LICENCIADA EN ENFERMERÍA

PRESENTADO POR:

Bach. Gresly Lucero PARIONA PALOMINO

ORCID: 0009-0008-5421-9872

ASESOR:

Dr. Manglio AGUIRRE ANDRADE

ORCID: 0000-0001-8234-567X

AYACUCHO – PERÚ

2026

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I: EL PROBLEMA	3
1.1. Contextualización del problema de investigación.....	3
1.2. Formulación de las preguntas norteadoras.....	4
1.3. Formulación de los objetivos de investigación	5
1.4. Viabilidad y consideraciones bioéticas	5
CAPÍTULO II: MARCO CONTEXTUAL	7
2.1. Descripción geográfica, territorial y ambiental del área de estudio	7
2.2. Características demográficas y estructura poblacional	7
2.3. Características socioculturales, lingüísticas y cosmovisión andina.....	8
2.4. Dinámica socioeconómica, vulnerabilidad y nivel de aseguramiento público	8
2.5. Características sanitarias, cartera de servicios y capacidad resolutive institucional.....	9
2.6. Articulación dialéctica del escenario físico-social con las dimensiones existenciales del usuario (Lebenswelt).....	10
CAPÍTULO III: ABORDAJE TEÓRICO	9
3.1. Antecedentes de estudio	9
3.2. Base teórica	10
3.3. Categorías de estudio (Matriz cualitativa y fenomenológica).....	11
CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA: DISEÑO FENOMENOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN.....	13
4.1. Fundamentación filosófica y epistemológica del diseño fenomenológico	13
4.2. Los cuatro existenciales de la experiencia humana vivida (van Manen y Sampieri)	13
4.3. Postura epistemológica, reflexividad y reducción fenomenológica (Epojé)	14
4.4. Selección del contexto, participantes informantes y saturación teórica	14
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de vivencias	14
4.6. Criterios de rigor científico cualitativo (Hernández-Sampieri, Cap. 14).....	15
4.7. Procedimiento sistemático de análisis fenomenológico de datos.....	16
CAPÍTULO V: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	18
5.1. Asignación de recursos humanos	18
5.2. Presupuesto	18
5.3. Financiamiento.....	19
5.4. Cronograma de actividades	19
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	21
ANEXOS	23
Anexo 1: Guía de entrevista a profundidad fenomenológica	23
Anexo 2: Matriz de consistencia cualitativa fenomenológica.....	24

Anexo 3: Formato de juicio de expertos	25
Anexo 4: Consentimiento informado	26
Anexo 5: Carta de asesoría formal	27

INTRODUCCIÓN

La calidad asistencial en el primer nivel de atención representa el eje vertebrador de los sistemas de salud pública y la garantía esencial del derecho fundamental a la salud. En los centros de atención primaria, la percepción del usuario sobre los cuidados y tratos recibidos condiciona el uso oportuno de los servicios, la adherencia a las terapias preventivo-recuperativas y la confianza hacia las instituciones sanitarias. En concordancia con los lineamientos metodológicos de la cátedra de Proyecto de Investigación en Salud (EN 486) de la Escuela Profesional de Enfermería (UNSCH), en el enfoque cualitativo la fundamentación y justificación del estudio se integran orgánicamente dentro de la Introducción, desarrollando las siguientes dimensiones sustantivas:

Importancia del proyecto: El Centro de Salud Belén, ubicado en el distrito de Ayacucho, cumple un rol estratégico como establecimiento de categoría I-3 que brinda cobertura a más de 18,000 habitantes en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. No obstante, persisten brechas asistenciales vinculadas a demoras prolongadas para la obtención de cupos, barreras comunicativas y hacinamiento en salas de espera. Investigar la experiencia del usuario permite develar la dimensión oculta de la calidad asistencial desde la perspectiva de quienes reciben directamente el cuidado, proveyendo a los gestores sanitarios insumos reflexivos para humanizar la atención.

Finalidad e impacto (valor práctico y social): El estudio tiene como finalidad práctica comprender en profundidad la vivencia subjetiva del usuario respecto al trato, tiempos de espera, información y privacidad. Sus hallazgos proporcionarán evidencia empírica directa para que el equipo directivo del Centro de Salud Belén, la Red de Salud Huamanga y el cuerpo de enfermería formulen estrategias interpersonales, planes de mejora continua y guías de trato humanizado con pertinencia cultural, orientadas a mitigar cuellos de botella en la atención primaria.

Valor teórico y clasificación por propósito: La presente investigación corresponde a una investigación básica (sustantiva) con nivel descriptivo-interpretativo y un riguroso diseño cualitativo fenomenológico (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Creswell, 2013). Su propósito central consiste en explorar, describir y comprender la esencia de las experiencias compartidas (vivencias) de los usuarios frente al fenómeno del acceso y la calidad asistencial en el Centro de Salud Belén, aprehendiendo sus cuatro dimensiones existenciales: temporalidad (tiempo vivido en madrugadas y esperas), espacialidad (espacio vivido en salas y consultorios), corporalidad (cuerpo doliente, fatiga y frío) y relacionalidad (encuentro interpersonal empático y diálogo en quechua chanka). Articula dialógicamente los modelos de Donabedian, Penchansky y Watson con la matriz cultural andina de Huamanga.

Valor metodológico: En el plano metodológico, el estudio adopta formalmente el diseño fenomenológico empírico y hermenéutico fundamentado en Edmund Husserl, Max van Manen, Clark Moustakas y John Creswell. Aporta y valida una guía de entrevista en profundidad y una matriz de categorización temática cualitativa ajustadas a los criterios de rigor de Guba y Lincoln (credibilidad, transferibilidad, consistencia y confirmabilidad), aplicando la técnica de triangulación de actores clave (usuarios, personal de salud y actores comunitarios).

Justificación institucional y sanitaria: El estudio se alinea estrictamente con los instrumentos rectores sanitarios: a nivel regional, responde a la Prioridad Regional 10 de la DIRESA Ayacucho 2025–2030 (“Organización, gestión, calidad y accesibilidad de los servicios de salud”); a nivel nacional, se adscribe a la Línea 10 de Investigación del MINSA al 2030 (“Sistemas y servicios de salud, acceso y cobertura universal”, RM N° 424-2025/MINSA) y al Plan Nacional de Humanización de la Atención en Salud.

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA

1.1. Contextualización del problema de investigación

En el marco de la investigación científica cualitativa, el planteamiento del problema adopta una naturaleza inductiva: no parte de deducciones hipotéticas preconcebidas ni de fórmulas numéricas abstractas, sino de la inmersión directa en una realidad concreta, latente y sentida por los actores sociales en su vida cotidiana. Plantear y delimitar el problema cualitativo constituye un proceso reflexivo, dinámico y flexible que demanda tiempo y apertura mental, permitiendo al investigador adaptar sus estrategias de aproximación para develar la esencia y la verdad del fenómeno humano.

Para tal fin, la metodología exige un contacto directo y vivencial con la realidad estudiada. En el presente estudio, el origen del problema se fundamenta en la propia subjetividad, observación reflexiva y experiencia acumulada por la investigadora durante sus prácticas preprofesionales y comunitarias de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) en los diferentes servicios del primer nivel de atención.

En el contexto territorial de Huamanga, el Centro de Salud Belén (establecimiento categoría I-3) cumple una labor asistencial estratégica al brindar atención preventiva y recuperativa a familias en condiciones de notable vulnerabilidad socioeconómica. No obstante, en la cotidianidad asistencial aflora una tensión constante: los usuarios madrugan desde las 4:00 o 5:00 de la madrugada para alcanzar un turno o cupo, afrontando la intemperie matutina, la incertidumbre en las filas, la saturación física de los pasillos y prolongadas horas de espera antes de ser llamados a los consultorios de Medicina, Crecimiento y Desarrollo (CRED), Inmunizaciones o Salud Sexual.

En este recorrido asistencial, se percibe una latente desconexión entre la destreza técnica de los procedimientos sanitarios y la calidad del encuentro interpersonal. Para la población ayacuchana —cuya matriz sociocultural e identidad lingüística está profundamente ligada al quechua chanka—, la atención en salud cobra significado a través de la calidez, la mirada directa, el saludo afectuoso, la paciencia explicativa y el respeto a su dignidad individual. Cuando estas pautas se omiten por la prisa o la sobrecarga del personal, el usuario experimenta sensaciones de desamparo, frustración o silencio. El verdadero problema radica en que los sistemas de gestión tradicionales evalúan la calidad únicamente mediante indicadores de cobertura numérica, desconociendo por completo las vivencias, emociones, mecanismos de respuesta y el sentido que los propios usuarios le atribuyen al cuidado de su salud.

Objeto de estudio principal: El fenómeno central que se investiga comprende la vivencia e interpretación intersubjetiva que le otorgan los usuarios a la atención recibida en el Centro de Salud Belén, desagregado en cinco dimensiones vivenciales:

- **Emociones y sentimientos experimentados:** Las vivencias afectivas (tranquilidad, angustia, impotencia, gratitud, desamparo o satisfacción) que se suscitan a lo largo de la atención.
- **Trayectoria y relatos de la experiencia cotidiana:** Los relatos y significados asignados a las filas de madrugada, la espera en salas y el tránsito por admisión, consultorios y farmacia.
- **Mecanismos de respuesta y afrontamiento del usuario:** Las conductas y estrategias (resignación, paciencia activa, reclamo formal o repliegue silencioso) desplegadas ante trabas o demoras.
- **Formas de interacción y trato interpersonal:** La calidez, cordialidad, empatía, escucha atenta y pertinencia lingüística intercultural (quechua-castellano) en el encuentro con el equipo de salud.
- **Significado holístico de la calidad del servicio:** La valoración global que construye el usuario sobre la dignidad del servicio y la confianza institucional depositada en el establecimiento.

1.2. Formulación de las preguntas norteadoras

En coherencia con el diseño fenomenológico de investigación (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Creswell, 2013) y la cátedra del Dr. Manglio Aguirre Andrade, se formulan preguntas norteadoras abiertas, orientadas a develar la esencia compartida y las estructuras universales de la experiencia vivida por los participantes, evitando hipótesis deductivas preconcebidas. Siguiendo la interrogante canónica de la fenomenología empírica:

Pregunta principal

¿Cuál es el significado, estructura y esencia de la experiencia vivida por los usuarios respecto al fenómeno del acceso y la calidad de atención en los servicios de salud del Centro de Salud Belén, Ayacucho 2026?

Preguntas específicas

1. ¿Cuáles son las emociones, sentimientos y sensaciones corporales (tranquilidad, angustia, fatiga o dolor) que vivencian los usuarios durante su tránsito por el Centro de Salud Belén?
2. ¿Cómo experimentan los usuarios la temporalidad de su trayectoria asistencial (madrugar a las 4:00 am, horas de espera en filas y demoras en consultorio)?

3. ¿Cómo perciben los usuarios la espacialidad del establecimiento (confort físico, hacinamiento, frío, orden y privacidad) y qué mecanismos de afrontamiento despliegan ante las limitaciones observadas?
4. ¿Cómo es la relacionalidad y el encuentro interpersonal (empatía, calidez, escucha atenta y comunicación intercultural en quechua chanka y castellano) entre los usuarios y el equipo de salud?
5. ¿Cuáles son los temas esenciales comunes y los elementos divergentes que configuran la esencia compartida del significado de la calidad asistencial para la comunidad de Belén?

1.3. Formulación de los objetivos de investigación

Guardando una simetría lógica estricta (1:1) con las preguntas norteadoras y empleando verbos analíticos propios de la investigación fenomenológica (Creswell, 2013; Sampieri, 2018), se determinan los siguientes objetivos:

Objetivo general

Comprender la estructura y esencia de la experiencia vivida por los usuarios respecto al acceso y la calidad de atención en los servicios de salud del Centro de Salud Belén, Ayacucho 2026.

Objetivos específicos

1. Develar las emociones, sentimientos y vivencias corporales que experimentan los usuarios a lo largo del proceso asistencial en el establecimiento.
2. Describir la temporalidad vivida en la trayectoria asistencial del usuario desde su arribo en la madrugada hasta la conclusión de su atención médica.
3. Identificar la vivencia de la espacialidad del centro de salud (condiciones físicas y privacidad) y los mecanismos de afrontamiento adoptados ante trabas asistenciales.
4. Caracterizar la relacionalidad y las formas de interacción interpersonal intercultural (en quechua y español) experimentadas en el encuentro con el equipo de salud.
5. Interpretar la esencia compartida y las categorías divergentes del significado de la calidad asistencial construidas por los usuarios a partir de sus vivencias cotidianas.

1.4. Viabilidad y consideraciones bioéticas

La presente investigación es plenamente viable puesto que cuenta con acceso expedito a las instalaciones del Centro de Salud Belén, disponibilidad de recursos humanos calificados, respaldo de la asesoría académica de la cátedra de investigación y

un presupuesto cubierto en su totalidad con recursos propios por la investigadora principal.

En estricta observancia del rigor bioético, el protocolo será remitido al Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI) de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) y coordinado formalmente ante las autoridades de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ayacucho y de la Red de Salud Huamanga antes de cualquier interacción con los participantes.

- **Principio de Autonomía:** Se garantizará la voluntariedad absoluta a través de la suscripción formal del Consentimiento Informado (Anexo 4), brindando explicaciones claras sobre la naturaleza del estudio en el idioma materno del usuario (quechua chanka o español).
- **Principio de Beneficencia y No Maleficencia:** Se evitará cualquier situación que genere incomodidad, angustia o alteración anímica. Las entrevistas se pausarán o suspenderán si el participante así lo requiere.
- **Principio de Justicia y Confidencialidad:** Se mantendrá el anonimato absoluto mediante el empleo de códigos alfanuméricos despersonalizados (ejemplo: Informante 01 – Inf. 01) en todas las fases de transcripción, análisis y redacción del informe de tesis.

CAPÍTULO II: MARCO CONTEXTUAL

En la investigación cualitativa bajo el diseño fenomenológico, el marco contextual no se reduce a una enumeración estática de datos cuantitativos ni a un inventario geográfico desvinculado; constituye la reconstrucción densa, profunda y holística del ambiente natural donde transcurre la vida cotidiana de las personas y donde se gesta el fenómeno estudiado (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Creswell, 2013). Para comprender la esencia de la experiencia vivida (Lebenswelt) de los usuarios respecto al acceso y la calidad de atención en el Centro de Salud Belén, es indispensable caracterizar la atmósfera física, cultural, social y sanitaria que envuelve, condiciona y dota de sentido a sus sentires, expectativas, frustraciones y valoraciones intersubjetivas (van Manen, 1990; DIRESA Ayacucho, 2025).

2.1. Descripción geográfica, territorial y ambiental del área de estudio

La investigación se sitúa en el Centro de Salud Belén, establecimiento sanitario cabecera perteneciente a la Microrred Huamanga de la Red de Salud Huamanga, adscrito a la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ayacucho. El establecimiento se localiza en el emblemático e histórico barrio de Belén, en el sector céntrico-sur del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, a una altitud oficial de 2,760 metros sobre el nivel del mar. Sus coordenadas geográficas de emplazamiento corresponden a los 13°09'47" de Latitud Sur y 74°13'28" de Longitud Oeste.

El territorio bajo su responsabilidad sanitaria se asienta en la subcuenca del río Alameda, dentro de la cuenca principal del valle de Huamanga. Limita por el norte con el casco monumental y urbano central de la ciudad de Huamanga; por el sur con las urbanizaciones periurbanas del distrito de San Juan Bautista; por el este con las faldas del cerro Acuchimay y el distrito de Carmen Alto; y por el oeste con la prolongación de la avenida Mariscal Cáceres y el jirón Bellido. Su orografía presenta una topografía moderadamente accidentada, con calles estrechas, empinadas y trazados coloniales que imponen un esfuerzo físico considerable a los usuarios con movilidad reducida, gestantes y personas de la tercera edad que acuden a pie.

El clima del área es templado y seco durante las horas diurnas soleadas, con temperaturas promedio anuales que oscilan entre los 15 °C y 22 °C. No obstante, una característica meteorológica decisiva para la experiencia del usuario radica en la marcada oscilación térmica interdiurna: durante las madrugadas andinas (entre las 4:00 a.m. y las 6:30 a.m.), el termómetro desciende habitualmente a valores de entre 5 °C y 8 °C, llegando a extremos menores en la temporada seca y de heladas (junio a agosto). Asimismo, se presenta una temporada de precipitaciones pluviales intensas entre los

meses de noviembre y marzo. Esta condición ambiental no constituye un dato accesorio, sino un determinante corpóreo directo: los usuarios que pugnan por conseguir una cita deben pernoctar a la intemperie en la vereda exterior del establecimiento expuestos al frío penetrante y a la lluvia, lo cual predispone a la fatiga somática y agrava sus dolencias de base.

En cuanto a la conectividad y accesibilidad vial, el establecimiento cuenta con acceso terrestre directo a través de arterias vehiculares pavimentadas (Jr. Bellido, Jr. Arequipa y Av. Mariscal Cáceres). El transporte urbano está garantizado mediante diversas líneas de transporte público (microbuses de las rutas 1, 3, 7 y 12), así como por una densa flota de mototaxis y taxis colectivos. A pesar de esta conectividad formal, el costo del pasaje y las barreras físicas del relieve obligan a un amplio porcentaje de familias vulnerables de sectores altos a realizar traslados peatonales de 20 a 40 minutos cargando niños en mantas tradicionales (llicllas) antes de la salida del sol.

2.2. Características demográficas y estructura poblacional

La jurisdicción sanitaria asignada al Centro de Salud Belén abarca una población diana proyectada de 18,450 habitantes según el Padrón Poblacional Oficial de la Red de Salud Huamanga (2025–2026). La pirámide poblacional se caracteriza por una base ensanchada en los primeros decenios de vida y una proporción creciente de personas adultas mayores, configurando un doble desafío asistencial de perfil materno-infantil y crónico-degenerativo. La distribución por etapas de vida es la siguiente:

- **Población Infantil (menores de 5 años):** Representa el 12.4% (2,288 niños), constituyendo el segmento con mayor intensidad de demanda en los consultorios preventivo-promocionales de Crecimiento y Desarrollo (CRED), tamizaje y tratamiento de anemia ferropénica, suplementación nutricional e inmunizaciones del esquema nacional regular.
- **Población Escolar y Adolescente (5 a 17 años):** Abarca el 19.6% (3,616 personas), demandantes de intervenciones de salud bucal, tamizaje visual, salud del escolar y orientación en salud sexual y reproductiva.
- **Población Joven y Adulta (18 a 59 años):** Constituye el 52.8% (9,742 personas), con un marcado predominio de mujeres en edad fértil (MEF) que acuden para control prenatal, despistaje de cáncer de cuello uterino, planificación familiar y atenciones médicas por patologías agudas.
- **Población Adulta Mayor (60 años a más):** Concentra el 15.2% (2,804 personas), un grupo en acelerado envejecimiento que presenta alta prevalencia de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, artrosis y secuelas

osteomusculares, requiriendo un acompañamiento asistencial continuo, trato digno y accesibilidad física preferencial.

Desde la mirada fenomenológica, resalta el fenómeno de la feminización de la demanda matutina: más del 70% de los usuarios que concurren a las salas de espera son mujeres. Se trata de madres de familia que acuden al cuidado y vigilancia de la salud de sus hijos menores, mujeres gestantes en controles prenatales y mujeres cuidadoras que asisten a adultos mayores dependientes. Esta dinámica impone sobre la mujer andina una sobrecarga cotidiana de roles, donde el tiempo de espera en el centro de salud compite directamente con sus jornadas de trabajo doméstico y comercial.

2.3. Características socioculturales, lingüísticas y cosmovisión andina

El entorno comunitario de Belén se distingue por una singular riqueza identitaria y una densa trama de sociabilidad popular. Históricamente, el barrio de Belén ha sido cuna de ilustres artesanos populares de Huamanga, reconocidos internacionalmente por el arte del retablo ayacuchano, la imaginería religiosa en yeso y el tallado tradicional en piedra de Huamanga. En este espacio geográfico coexisten familias tradicionales residentes desde hace generaciones con oleadas de población migrante provenientes de las zonas rurales y provincias del centro-sur ayacuchano (Víctor Fajardo, Cangallo y Vilcas Huamán), muchas de ellas asentadas a raíz de la violencia sociopolítica de las décadas pasadas.

En el plano lingüístico, el 72% de la población usuaria es bilingüe activa en quechua chanka y castellano. En las generaciones de adultos mayores y en mujeres migrantes de sectores periféricos, el quechua constituye la lengua materna predominante y el vehículo exclusivo para verbalizar el sufrimiento corpóreo y anímico. Para la cosmovisión andina huamanguina, los padecimientos no son meras disfunciones biológicas aisladas, sino alteraciones del equilibrio integral del ser humano con su entorno, expresadas en nociones complejas como el dolor visceral (nanay), el estado de enfermedad integral (onqoy), la tristeza y aflicción acumulada (llakikuy), el enfriamiento del cuerpo (chiriyay) o los desórdenes espirituales derivados del espanto o susto (mancharisqa).

Las pautas de sociabilidad comunitaria exigen de manera indeclinable la observancia de códigos éticos y de cortesía tradicionales basados en el respeto mutuo (respetanakuy), el saludo formal y afectuoso (napaykuy) y la acogida hospitalaria (allin chaskiy) (Aguirre-Andrade et al., 2020). Cuando el personal de salud —frecuentemente hispanohablante monolingüe o condicionado por la prisa protocolar— prescinde del saludo, evita el contacto visual, interrumpe el relato del usuario o emplea un léxico excesivamente tecnicista, se produce un violento quiebre comunicativo. El usuario andino interpreta esta conducta como desdén, frialdad burocrática, soberbia institucional

o discriminación clasista y étnica, replegándose en el silencio (upallay) y perdiendo la confianza en el sistema asistencial.

En cuanto al nivel de instrucción, el 48% de los jefes de familia cuenta con educación secundaria completa, un 26% posee secundaria incompleta o primaria, y un 8% (concentrado en adultos mayores) registra analfabetismo formal o funcional. Esta realidad representa un desafío crítico para la alfabetización en salud, pues muchos usuarios no logran descifrar las recetas médicas escritas, los calendarios de citas o la señalética institucional de los consultorios, dependiendo enteramente de la orientación verbal empática que el profesional de enfermería pueda suministrarle.

2.4. Dinámica socioeconómica, vulnerabilidad y nivel de aseguramiento público

La actividad socioeconómica de los hogares usuarios del Centro de Salud Belén se inserta de manera mayoritaria en el régimen de la economía popular informal y de subsistencia diaria. La Población Económicamente Activa (PEA) labora preponderantemente en el comercio ambulatorio de verduras, frutas y alimentos preparados en el Mercado Central de Belén y su concurrida feria sabatina; en el transporte menor mediante la conducción de mototaxis; en faenas eventuales de construcción civil (albañilería y peonaje); en talleres artesanales independientes; y en el trabajo doméstico no remunerado o remunerado por jornada.

De acuerdo con los registros del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), el 68.2% de las familias del ámbito de influencia se encuentra clasificada en situación de pobreza y pobreza extrema. En coherencia con este perfil de precariedad material, el 94.5% de la población usuaria se encuentra afiliada al régimen subsidiado del Seguro Integral de Salud (SIS).

Esta dependencia casi total del aseguramiento público estatal confiere una trascendencia vital a la gratuidad del servicio. Los usuarios acuden al centro asistencial bajo la certeza legítima de que el Estado proveerá tanto el acto médico como los medicamentos necesarios para su recuperación. Cuando la farmacia del establecimiento incurre en roturas de stock o desabastecimiento de medicamentos esenciales (como antibióticos de primera línea, antipiréticos, micronutrientes para la anemia o fármacos antihipertensivos), se suscita una crisis devastadora en la economía doméstica: el usuario se ve conminado a realizar un gasto de bolsillo imprevisto en las boticas y farmacias comerciales privadas que proliferan en los alrededores del centro de salud. Para una madre que vive de las ganancias del día a día en el mercado, destinar 20 o 30 soles a la compra de fármacos implica desfinanciar la alimentación diaria del hogar, vivencia que es experimentada con honda amargura, desesperanza e impotencia frente a la precariedad del sistema público.

2.5. Características sanitarias, cartera de servicios y capacidad resolutive institucional

El Centro de Salud Belén se encuentra formalmente categorizado como un establecimiento de salud del primer nivel de atención de nivel I-3 (sin internamiento hospitalario), desempeñando un papel neurálgico como cabecera de microred asistencial. Su misión operativa consiste en brindar atención integral ambulatoria, promocional, preventiva y de recuperación básica para descongestionar el Hospital Regional de Ayacucho “Miguel Ángel Mariscal Llerena” (Nivel III-1).

A continuación se detalla la oferta prestacional y la distribución del talento humano asistencial disponible en el establecimiento:

Cartera de Servicios	Actividades Asistenciales Principales	Turno	Personal Asignado
Medicina General	Consulta ambulatoria, diagnóstico clínico, prescripción médica y atención de morbilidades agudas y crónicas.	Mañana / Tarde	04 Médicos Cirujanos
Enfermería (CRED e Inmunizaciones)	Control del crecimiento y desarrollo del niño, tamizaje de anemia, vacunación del esquema regular y consejería nutricional.	Mañana / Tarde	06 Lic. en Enfermería
Enfermería (TBC y No Transmisibles)	Control de tuberculosis (PCT), administración de tratamiento DOTS, tamizaje de hipertensión arterial y diabetes mellitus.	Mañana	02 Lic. en Enfermería
Obstetricia (Salud Reproductiva)	Control prenatal, psicoprofilaxis obstétrica, monitoreo fetal básico, planificación familiar y tamizaje de cáncer ginecológico.	Mañana / Tarde	04 Lic. en Obstetricia
Odontología	Odontología preventiva y restauradora, exodoncias simples, profilaxis dental y fluorización tópica.	Mañana / Tarde	02 Cirujanos Dentistas
Psicología	Atención de salud mental, tamizaje de violencia familiar, intervención en crisis y consejería psicológica.	Mañana	02 Lic. en Psicología
Tópico de Urgencias y Triage	Evaluación de signos vitales, curaciones menores, suturas simples, administración de inyectables y nebulizaciones.	12 Horas continuas	04 Técnicos de Enfermería
Farmacia SIS	Almacenamiento, custodia y dispensación ambulatoria de medicamentos del petitorio oficial para afiliados SIS.	12 Horas continuas	02 Técnicos de Farmacia
Laboratorio Básico	Toma de muestras biológicas, hematócrito/hemoglobina, frotis sanguíneo, examen de orina y baciloscopías.	Mañana	01 Tecnólogo / Técnico

El perfil epidemiológico de la demanda ambulatoria está hegemonizado por las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA),

parasitosis intestinal, anemia por deficiencia de hierro en niños menores de 36 meses, infecciones del tracto urinario (ITU) en mujeres en edad fértil y gestantes, lumbalgias mecánicas derivadas del trabajo físico, y patologías crónicas no transmisibles (hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2) en adultos mayores.

No obstante su relevancia estratégica, el establecimiento enfrenta una serie de nudos críticos institucionales y barreras operativas que inciden directamente en la subjetividad del usuario:

1. **Mecanismo de asignación de cupos matutinos (tickets):** El establecimiento oferta un número restringido de atenciones médicas por turno (generalmente entre 12 y 16 cupos por consultorio médico), limitadas estrictamente a la jornada asistencial de 6 horas. Esta restricción cuantitativa obliga a los usuarios a disputarse los turnos desde tempranas horas de la madrugada, generando un clima de zozobra e incertidumbre donde muchas personas, tras aguardar horas en la fila exterior, reciben la notificación de que los cupos se han agotado.
2. **Limitaciones arquitectónicas y hacinamiento espacial:** El centro de salud funciona en un inmueble cuya infraestructura original ha sido sucesivamente adaptada, presentando pasillos estrechos, salas de espera techadas pero con escaso aislamiento térmico y bancas metálicas insuficientes. La tabiquería provisional entre consultorios adolece de aislamiento acústico, lo que provoca la filtración de conversaciones clínicas y quebranta el derecho a la privacidad e intimidad corporal y emocional de los pacientes.
3. **Inestabilidad laboral y sobrecarga burocrática:** Una fracción considerable del personal profesional y técnico se encuentra bajo regímenes de contratación temporal transitoria (CAS), lo que origina una continua rotación de profesionales que interrumpe la continuidad del vínculo afectivo con los pacientes de la comunidad. A ello se suma la sobrecarga de digitación en los sistemas informáticos (HIS-MINSA y formato FUA-SIS), la cual absorbe gran parte del tiempo de consulta, obligando al profesional a interactuar con la pantalla del computador en detrimento del contacto visual con el usuario.

2.6. Articulación dialéctica del escenario físico-social con las dimensiones existenciales del usuario (Lebenswelt)

En concordancia con los postulados epistemológicos de Max van Manen (1990), John Creswell (2013) y Roberto Hernández-Sampieri (2018), el mundo de la vida (Lebenswelt) de los seres humanos se articula indisolublemente a través de cuatro existenciales universales: la temporalidad, la espacialidad, la corporalidad y la relacionalidad. El marco contextual del Centro de Salud Belén no actúa como un mero telón de fondo pasivo, sino que opera como un escenario dialéctico que condiciona y da

forma a cada una de estas dimensiones existenciales, tal como se sintetiza a continuación:

Dimensión Existencial (Lebenswelt)	Manifestación Empírica en el Contexto de Belén	Significado Vivencial y Afectivo Construido por el Usuario
Temporalidad (Tiempo vivido)	Despertar forzado a las 4:00 a.m.; horas de vigilia en la vereda a la espera de la apertura del portón (7:00 a.m.); lapsos prolongados de espera en salas (2 a 3 horas) frente a una consulta médica de apenas 10 a 15 minutos.	Vivencia del tiempo suspendido, angustia e impotencia ante la posibilidad de perder el cupo. Disparidad percibida entre el enorme sacrificio temporal realizado y la brevedad del contacto clínico.
Espacialidad (Espacio vivido)	La vereda exterior pública; el portón de rejas de metal; los pasadizos estrechos abarrotados de pacientes; consultorios con paredes divisorias delgadas que dejan filtrar voces e intimidades; ventanilla de admisión con rejas o vidrio.	Sensación de hacinamiento, exposición pública y pérdida de intimidad. La ventanilla y el portón operan como fronteras físicas y simbólicas que separan al usuario del poder biomédico institucional.
Corporalidad (Cuerpo vivido)	Frío lacerante de la madrugada andina (5 °C a 8 °C); fatiga física muscular por permanecer de pie durante horas; hambre y sed por asistir en ayunas; llanto de los infantes acatarrados en mantas; dolores articulares intensificados por la intemperie.	El cuerpo enfermo no es un objeto abstracto: es el asiento directo de la vulnerabilidad física, el dolor y la incomodidad somática. El acto asistencial es ansiado como un alivio palpable a la opresión del cuerpo.
Relacionalidad (Relación vivida con los otros)	Encuentro intersubjetivo entre el usuario quechua-mestizo vulnerable y el personal sanitario; presencia del saludo cordial (napaykuy) o su omisión; mirada a los ojos frente a la mirada fija en el monitor; paciencia explicativa o respuestas cortantes.	La calidad se define en la dignidad del trato interpersonal: el usuario busca acogida humana (allin chaskiy), respeto mutuo (respetanakuy) y comprensión en su propia lengua. La calidez del cuidado de enfermería transforma el desamparo en alivio y gratitud.

Esta articulación multidimensional confirma que, para el usuario del Centro de Salud Belén, la “calidad de atención” trasciende ampliamente los parámetros gerenciales o el abastecimiento técnico; constituye una experiencia existencial totalizante donde el cuerpo aterido, el tiempo sacrificado, el espacio habitado y el trato humano recibido configuran la esencia de su satisfacción o sufrimiento frente al sistema público de salud.

CAPÍTULO III: ABORDAJE TEÓRICO

3.1. Antecedentes de estudio

3.1.1. *Antecedentes internacionales*

- **Gómez-Restrepo y colaboradores (2023, Colombia):** Realizaron una investigación cualitativa fenomenológica titulada “Experiencia del usuario sobre la calidad asistencial en el primer nivel de atención”. Analizaron 18 entrevistas a profundidad con usuarios de centros de salud urbanos, concluyendo que la percepción de calidad está dominada por la calidez comunicativa y la empatía del personal. Demostraron que el trato humanizado compensa percibidamente las deficiencias del ambiente físico y reduce la frustración asociada a los tiempos de espera prolongados.
- **Pérez y Silva (2022, Ecuador):** En su estudio cualitativo “Significados de la atención de enfermería desde la mirada del paciente externo”, concluyeron que los usuarios valoran principalmente el saludo, la escucha atenta y la mirada a los ojos por parte del personal de enfermería, considerando estos gestos como indicadores fundamentales de respeto y competencia profesional.

3.1.2. *Antecedentes nacionales*

- **Mamani y Quispe (2024, Lima):** En su investigación cualitativa “Percepción de la calidad del cuidado de enfermería en usuarios de establecimientos de salud del primer nivel”, determinaron que los usuarios asocian la mala calidad no al diagnóstico médico sino a la frialdad en la atención, el uso excesivo de modismos técnicos y la falta de espacio para formular preguntas sobre sus medicamentos.
- **Córdova y Reyes (2023, Arequipa):** Desarrollaron el estudio “Tiempos de espera y trato humano: Un estudio cualitativo en centros de salud públicos”. Identificaron que la larga espera en filas desde tempranas horas de la mañana genera una predisposición negativa en el usuario, la cual solo logra disiparse cuando el profesional de enfermería brinde una acogida empática e informativa.

3.1.3. *Antecedentes regionales y locales*

- **Rojas (2023, Ayacucho):** En su tesis cualitativa “Percepción intercultural de la calidad de atención en usuarios de centros de salud de la Red Huamanga”, realizada con usuarios quechuahablantes, concluyó que la barrera lingüística es el principal factor de insatisfacción. Evidenció que cuando el personal de salud

o enfermería responde o saluda en quechua, la percepción de calidad y confianza institucional se incrementa significativamente.

- **García (2022, Ayacucho - UNSCH):** En su trabajo de investigación sobre “Cuidado humanizado de enfermería en el primer nivel de atención”, reportó que la sobrecarga asistencial del personal suele minar la paciencia en el trato, afectando la percepción que tiene la madre o el adulto mayor sobre la atención brindada en los servicios preventivo-promocionales.

3.2. Base teórica

Modelo de Calidad de Salud de Avedis Donabedian

Constituye el marco conceptual de referencia para evaluar la calidad sanitaria. Donabedian establece tres dimensiones entrelazadas:

1. **Estructura:** Engloba los recursos materiales (infraestructura, equipamiento, insumos), financieros y humanos (número y calificación del personal).
2. **Proceso:** Refiere a las actividades asistenciales interpersonales y técnicas que ocurren entre el profesional de salud y el paciente.
3. **Resultado:** Evalúa las modificaciones en el estado de salud del paciente y la satisfacción subjetiva obtenida tras el servicio.

Teoría del Cuidado Humano de Jean Watson

Sostiene que el cuidado es el núcleo filosófico y práctico de la enfermería. Define al cuidado como un proceso transpersonal e intersubjetivo que busca armonizar la mente, el cuerpo y el alma del ser humano. Watson plantea la necesidad de cultivar relaciones de ayuda y confianza, caracterizadas por la empatía, la sensibilidad, el respeto y la escucha activa.

Fundamentos del Cuidado Fenomenológico en Enfermería: Patricia Benner y Holly Wilson

En el campo de la enfermería y las ciencias de la salud, la fenomenología constituye el diseño por excelencia para aprehender la esencia íntima del cuidado, la vulnerabilidad humana y el sufrimiento (Norlyk y Harder, 2010; Sampieri y Mendoza, 2018). Como postula Patricia Benner (2008), la práctica del cuidado de enfermería es fundamentalmente una práctica encarnada (*embodied practice*), donde el cuerpo del paciente no es un objeto mecánico, sino el vehículo a través del cual la persona vivencia el dolor, la angustia, el frío y el alivio. Benner fundamenta que la calidad asistencial emerge en el encuentro intersubjetivo, donde la intuición clínica y la presencia sensible de la enfermera permiten descifrar el sentir del paciente más allá de los signos biomédicos.

Asimismo, Holly Skodol Wilson (2007) y Norlyk y Harder (2010) señalan que el diseño fenomenológico en salud tiene por propósito primordial describir la esencia de las experiencias de los pacientes, exigiendo que el investigador 'haga a un lado' (bracketing o epojé) sus presupuestos teóricos para dar cabida a las narrativas auténticas de los usuarios. Esta concepción se engarza de manera natural con el contexto del Centro de Salud Belén, donde las vivencias de las madres en CRED, los adultos mayores y las familias quechuahablantes requieren ser develadas desde su propia cotidianidad.

3.3. Categorías de estudio (Matriz cualitativa y fenomenológica)

En concordancia con el paradigma inductivo interpretativo y las directrices metodológicas de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018, p. 494), en el diseño fenomenológico las unidades de significado se estructuran dialécticamente en: (a) Categorías esenciales o comunes de las narrativas (vivencias compartidas por la colectividad usuaria respecto a madrugadas, espera, empatía y quechua); y (b) Categorías diferentes o divergentes de las narrativas (valoraciones y matices particulares disonantes según edad, servicio o condición socioeconómica). A continuación se presenta la matriz comprensiva con las definiciones operativas, códigos sugeridos y preguntas orientadoras:

Concepto Potencial	Dimensión Existencial	Definición Conceptual / Significado	Categorías Emergentes y Códigos	Pregunta Guía de Profundización
Calidad de Atención y Cuidado Humano	1. Temporalidad (Tiempo vivido)	Experiencia subjetiva del transcurso del tiempo: madrugar a oscuras, incertidumbre en la fila exterior y horas en sala de espera.	• Esencia compartida: Madrugar a las 4:00 AM; angustia por alcanzar cupo; tiempo detenido en sala. • Variaciones individuales: Percepción de mayor agilidad en CRED que en Medicina; jóvenes valoran citas digitales, adultos mayores la fila presencial.	¿Cómo vivió subjetivamente el transcurrir de las horas desde su llegada en la madrugada hasta su ingreso al consultorio?
	2. Espacialidad (Espacio vivido)	Vivencia del entorno físico, ambiental y simbólico: acera exterior, hacinamiento en pasillos, rigidez de asientos y privacidad	• Esencia compartida: Frío de la acera matutina; estrechez de pasillos; alivio al entrar a un ambiente reservado. • Variaciones individuales:	¿Cómo describe el espacio físico por donde transitó? ¿Sintió que el consultorio le brindó la intimidad y tranquilidad

		clínica.	Consultorios de Obstetricia con mayor reserva que Triage; disonancia sobre la ventilación en lluvias.	necesaria?
	3. Corporalidad (Cuerpo vivido)	Sentires somáticos y físicos de la persona doliente: fatiga física, hambre en ayunas, frío penetrante, dolor de la afección y alivio corporal.	• Esencia compartida: Cansancio lumbar por estar de pie; frío matutino; distensión corporal al ser atendido y recibir medicinas. • Variaciones individuales: Madres reportan llanto y cansancio de los niños; adultos mayores expresan dolor articular y entumecimiento.	¿Qué sensaciones experimentó en su cuerpo (dolor, fatiga, frío, alivio) a lo largo de toda su espera y atención clínica?
	4. Relacionalidad (Relación humana)	Vínculo intersubjetivo entre el equipo asistencial y el usuario: saludo afectuoso (napaykuy), empatía, escucha activa y lengua quechua.	• Esencia compartida: Necesidad vital de calidez y mirada atenta; consuelo al ser escuchado; dignidad al comunicarse en quechua chanka. • Variaciones individuales: Trato cercano en Enfermería frente a mayor prisa en Medicina; quejas de indiferencia en Admisión.	¿Cómo fue el encuentro humano con el médico o enfermera? ¿Sintió calidez, paciencia y escucha atenta? ¿Le hablaron en quechua?
	5. Esencia Holística del Cuidado	Significado integral y valorativo que el usuario otorga a la atención digna, humanizada y resolutive en el primer nivel de salud.	• Esencia compartida: Calidad significa respeto irrestricto, comprensión del dolor y entrega oportuna de fármacos. • Variaciones individuales: Pacientes crónicos priorizan abastecimiento de insumos; madres primerizas priorizan paciencia y pedagogía.	Al reflexionar sobre toda su vivencia, ¿qué significa para usted recibir una atención de auténtica calidad humana?

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA: DISEÑO FENOMENOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN

4.1. Fundamentación filosófica y epistemológica del diseño fenomenológico

La investigación se inserta en el paradigma interpretativo-naturalista y adopta un diseño cualitativo fenomenológico (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Creswell, 2013). Como señalan Roberto Hernández-Sampieri y Christian Mendoza (2018), la fenomenología no es únicamente una técnica de indagación, sino simultáneamente una filosofía, un enfoque epistemológico y un diseño metodológico riguroso cuyo origen se remonta al matemático y filósofo Edmund Husserl (1859-1938). Su propósito principal consiste en explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un determinado fenómeno y descubrir los elementos en común (la esencia compartida) de tales vivencias.

- **Diferenciación frente a la Teoría Fundamentada:** En la teoría fundamentada se busca generar un modelo teórico abstracto a partir de las perspectivas de los participantes; en contraste, en la fenomenología los investigadores trabajan directamente con las unidades o declaraciones de los participantes y sus vivencias, más que abstraerlas para crear un modelo basado en interpretaciones preconcebidas (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p. 493). Los datos provienen de sentimientos, emociones, razonamientos y percepciones corporales directas.
- **Diferenciación frente al Diseño Narrativo:** Mientras que el diseño narrativo se enfoca en la conexión o sucesión cronológica de eventos (el punto de vista biográfico o temporal), el diseño fenomenológico se enfoca de manera exclusiva en la esencia de la experiencia compartida (lo que vivenciaron y cómo lo vivenciaron).
- **Diferenciación frente a Etnografía e Investigación-Acción:** No persigue describir patrones macro-culturales de una comunidad a lo largo de años (etnografía), ni implementar intervenciones experimentales directas (investigación-acción), sino capturar con fidelidad la esencia íntima del fenómeno asistencial vivido.
- **Articulación de dos vertientes fenomenológicas:** Integra armónicamente la fenomenología empírica o trascendental (Moustakas, 1994; Creswell, 2013; Wilson, 2007), donde la investigadora aparta mediante epojé sus propios presupuestos para describir la vivencia pura del paciente; y la fenomenología hermenéutica (van Manen, 1990), que permite interpretar el sentido latente de las narrativas en su matriz sociocultural andina quechua chanka.

4.2. Los cuatro existenciales de la experiencia humana vivida (van Manen y Sampieri)

Siguiendo a Hernández-Sampieri y Mendoza (2018, p. 494) y Max van Manen (1990), el diseño fenomenológico contextualiza las experiencias en cuatro dimensiones fundamentales del mundo de la vida (Lebenswelt):

1. **Temporalidad (el tiempo vivido):** El momento en que ocurrieron los hechos y el tiempo percibido. En el C.S. Belén se manifiesta en el madrugar a las 4:00 am, la angustia previa a la apertura de ventanilla, el tiempo detenido en las bancas de espera y la sensación de sosiego o prisa en la consulta.
2. **Espacialidad (el espacio vivido):** El lugar físico y ambiental donde sucedieron las vivencias: la frialdad de la acera matutina, el hacinamiento en pasillos, la rigidez de asientos y la reserva o vulneración de la intimidad dentro del consultorio.
3. **Corporalidad (el cuerpo vivido):** La dimensión somática de las personas que vivencian el fenómeno: el frío matutino calando el cuerpo, el cansancio muscular por horas de pie, la fatiga del ayuno, el llanto del lactante y el dolor somático que motiva la consulta médica.
4. **Relacionalidad (la relación humana vivida):** Los lazos interpersonales y encuentros intersubjetivos gestados en la atención: el saludo cordial (napaykuy), el contacto visual, la empatía, la calidez o frialdad del personal y el diálogo fluido en quechua chanka.

4.3. Postura epistemológica, reflexividad y reducción fenomenológica (Epojé)

En contraste con la neutralidad aséptica positivista, la investigadora asume un rol de proximidad sensible y reflexividad rigurosa guiada por tres pilares:

- **Práctica de la Reducción Fenomenológica (Epojé / Bracketing):** Siguiendo a Husserl (1949), Moustakas (1994) y Creswell (2013), la investigadora suspende reflexivamente sus propios juicios previos, experiencias previas como estudiante de enfermería y prejuicios clínicos, para recibir los relatos de los usuarios con total apertura y pureza fenoménica.
- **Construcción de Confianza (Rapport):** Generar un vínculo horizontal de respeto mutuo y calidez humana indispensable para que los informantes exterioricen vivencias íntimas sin temor a ser juzgados.
- **Empatía Intercultural Andina:** Comprender el sentir del usuario desde su propia cosmovisión y condición socioeconómica, dialogando fluidamente en quechua chanka y castellano.

4.4. Selección del contexto, participantes informantes y saturación teórica

Criterio de Selección y Muestreo: Siguiendo a Hernández-Sampieri y Mendoza (2018, p. 493) y Creswell (2013), en el diseño fenomenológico los participantes se seleccionan porque han experimentado en carne propia el fenómeno de interés bajo estudio. Se adopta un muestreo cualitativo no probabilístico intencional, regulado por el principio de saturación teórica (Esbensen et al., 2008), estimándose una muestra referencial de 12 a 18 informantes clave.

Criterios de Inclusión:

1. Usuarios de ambos sexos, mayores de 18 años, que hayan recibido atención en Medicina, Enfermería (CRED, Inmunizaciones), Obstetricia u Odontología del C.S. Belén en los últimos tres meses.
2. Participación estrictamente voluntaria formalizada mediante la firma o huella dactilar del Consentimiento Informado (Anexo 4).
3. Capacidad de verbalizar y comunicar sus vivencias y emociones en español o quechua chanka.

Criterios de Exclusión:

1. Personas con compromiso neurológico agudo o alteraciones del lenguaje que impidan el diálogo fluido.
2. Usuarios que acudan exclusivamente a realizar gestiones burocráticas breves en ventanilla sin haber recibido atención clínica asistencial.

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de vivencias

- **Entrevista Fenomenológica en Profundidad:** Técnica central (45 a 60 minutos por sesión) conducida mediante preguntas abiertas diseñadas para reconstruir el significado, la estructura y la esencia de la vivencia asistencial (Anexo 1) (Creswell, 2013; Norlyk y Harder, 2010).
- **Observación Reflexiva no Participante:** Registro detallado de la dinámica ambiental, tiempos de espera, gestos corporales y clima relacional en salas de espera y consultorios.
- **Diario de Campo y Notas de Inmersión:** Registro sistemático de impresiones inmediatas, silencios, inflexiones de voz y notas de reflexividad pos-entrevista.
- **Triangulación de Actores Clave:** Articulando el modelo pedagógico del Dr. Manglio Aguirre Andrade, se triangulan tres perspectivas: (a) Usuarios externos / pacientes (vivencia sentida directa); (b) Personal asistencial de salud y enfermería (retos operativos del servicio); y (c) Acompañantes y actores comunitarios (mirada colectiva y social).

4.6. Criterios de rigor científico cualitativo (Hernández-Sampieri, Cap. 14)

En la investigación cualitativa se reemplazan radicalmente los conceptos positivistas de validez y confiabilidad estadística por los cuatro criterios de rigor cualitativo formulados por Roberto Hernández-Sampieri, Carlos Fernández-Collado y Pilar Baptista-Lucio (2014, Cap. 14), articulados con los fundamentos de Lincoln y Guba (1985):

Criterio de Rigor (Sampieri)	Definición Metodológica	Estrategia Operativa de Aseguramiento
1. Dependencia (Consistencia Cualitativa)	Coherencia interna y estabilidad en los procedimientos de recolección y sistematización de los testimonios.	• Pistas de auditoría transparentes. • Registro exhaustivo en la bitácora de campo. • Protocolo estandarizado de transcripción fonética y codificación.
2. Credibilidad (Validez Interna)	Fidelidad con la que las interpretaciones reflejan los significados reales vivenciados por los participantes.	• Triangulación múltiple de métodos y fuentes. • Transcripción íntegra palabra por palabra (verbatim). • Verificación y chequeo con los participantes (member checking).
3. Transferencia (Aplicabilidad Contextual)	Posibilidad de transferir los significados a otros contextos con características ecológicas y sociales análogas.	• Descripción densa y contextualizada del C.S. Belén (Capítulo II). • Caracterización sociocultural y lingüística detallada de los informantes.
4. Confirmabilidad (Neutralidad Reflexiva)	Garantía de que los hallazgos surgen de las vivencias reales y no de sesgos o prejuicios del investigador.	• Práctica rigurosa de la epojé o bracketing fenomenológico. • Memos analíticos reflexivos continuos. • Auditoría externa y revisión crítica con el asesor Dr. Manglio Aguirre.

4.7. Procedimiento sistemático de análisis cualitativo fenomenológico (Sampieri, Cap. 14 y 15)

El análisis se rige por las acciones secuenciales de la Figura 15.14 de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018, p. 495), articuladas con los métodos de Colaizzi (1978), Moustakas (1994) y Creswell (2013):

- 1. Transcripción íntegra y fonética (verbatim):** Conversión exacta palabra por palabra de los audios a texto digital dentro de las 24 horas posteriores a la entrevista, preservando pausas y giros en quechua chanka.
- 2. Lectura holística general:** Inmersión lectora reflexiva en la totalidad de las descripciones para aprehender el sentido global de las vivencias.

3. **Identificación de unidades de análisis y horizontalización (horizontalization):** Detección de todas las frases y declaraciones clave vinculadas a la experiencia asistencial, otorgando igual valor epistémico inicial a cada testimonio.
4. **Generación de categorías esenciales vs. divergentes:** Estructuración en la matriz analítica de Sampieri y Mendoza (2018, p. 494): (a) Categorías esenciales o comunes (temas compartidos por todos los participantes); y (b) Categorías diferentes o divergentes (apreciaciones y valoraciones disonantes según edad o servicio).
5. **Construcción de descripciones texturales y estructurales:** Elaboración de la descripción textural (lo que experimentaron objetivamente) y la descripción estructural (cómo y bajo qué condiciones de temporalidad, espacialidad, corporalidad y relacionalidad lo vivenciaron).
6. **Síntesis de la esencia compartida del fenómeno:** Integración armónica de las descripciones en una narrativa densa que sintetiza la esencia compartida del fenómeno de la calidad asistencial y el acceso.
7. **Validación testimonial con los participantes (member checking):** Devolución de la síntesis a una muestra de participantes informantes para constatar que el reporte refleje fielmente el núcleo de sus experiencias vividas.

CAPÍTULO V: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

5.1. Asignación de recursos humanos

- **Investigadora principal:** 01 (Gresly Lucero Pariona Palomino, Estudiante de la E.P. Enfermería).
- **Asesor del proyecto:** Dr. Manglio Aguirre Andrade (Docente de la FCS - UNSCH).
- **Personal de apoyo:** 02 (Transcripción e intérprete de quechua).

5.2. Presupuesto

PAGO DE SERVICIOS DE PERSONAL

SERVICIOS	U.M	CANTIDAD	C. UNIT. S/.	TOT. S/.
Coasesor / Especialista temático	Mes	04	500.00	2000.00
Personal de apoyo (02)	Mes	02	500.00	1000.00
SUB TOTAL				3000.00

PROGRAMACIÓN DE OTROS SERVICIOS

SERVICIOS	U.M	CANTIDAD	C. UNIT. S/.	TOT. S/.
Impresiones y fotocopias	Hojas	1000	0.20	200.00
Internet y conectividad	Hora	200	1.00	200.00
Procesamiento y codificación cualitativa	Unidad	01	500.00	500.00
Empastado de tesis/proyectos	Unidad	05	20.00	100.00
Traslado y movilidad local	Días	20	10.00	200.00
SUB TOTAL				1200.00

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y OTROS

MATERIALES	U.M	CANTIDAD	C. UNIT. S/.	TOT. S/.
Material bibliográfico especializado	Unidad	02	50.00	100.00

Papel Bond A4 80 gr.	Millar	02	25.00	50.00
Memoria USB 32 GB	Unidad	02	40.00	80.00
Carpetas y folders	Unidad	10	1.00	10.00
Lapiceros y resaltadores	Unidad	10	2.00	20.00
Mascarillas KN95 y bioseguridad	Caja	02	20.00	40.00
Alcohol en gel / líquido 70%	Litro	02	10.00	20.00
Imprevistos / Otros	Global	01	80.00	80.00
SUB TOTAL				400.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: S/. 4,600.00 Soles

5.3. Financiamiento

El proyecto de investigación será autofinanciado de manera integral por la investigadora principal.

5.4. Cronograma de actividades

El dimensionamiento temporal del proyecto se sustenta en la técnica de evaluación y revisión de programas (PERT), calculándose el tiempo estimado (te) mediante la formulación: $te = (O + 4m + P) / 6$, donde O representa el tiempo optimista, m el tiempo más probable y P el tiempo pesimista.

Asimismo, tal como enfatizó el docente en la cátedra de EN 486, la planificación administrativa de una tesis de pregrado debe ponderar con realismo la brecha existente entre los plazos normativos formales y la realidad académica universitaria: la formulación rigurosa del proyecto demanda aproximadamente cuatro meses tras culminar el ciclo académico (Serie 47); los trámites de dictamen y aprobación ante el Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI) y el Consejo de Facultad suelen tomar entre seis a ocho meses en la práctica; y la fase de ejecución de campo exige un periodo indispensable de al menos tres meses para garantizar inmersión reflexiva, construcción de confianza interpersonal con los informantes y saturación teórica efectiva. Con base en este análisis crítico, se establece un horizonte operativo sistemático de seis (06) meses para la fase de ejecución y dictamen final, programado de agosto de 2026 a enero de 2027.

Actividades	Ago 2026	Set 2026	Oct 2026	Nov 2026	Dic 2026	Ene 2027
Presentación del proyecto	X					
Aprobación del proyecto		X				
Validación de instrumentos			X			
Revisión del marco teórico			X	X		
Coordinación con el establecimiento de salud				X		
Recolección de datos (entrevistas)				X	X	
Transcripción y procesamiento cualitativo					X	
Análisis cualitativo e interpretación					X	
Presentación del informe final						X
Sustentación de la tesis						X

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Hernández-Sampieri R, Mendoza CP. Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Ciudad de México: McGraw-Hill; 2018.
- [2] Donabedian A. The definition of quality and approaches to its assessment. Ann Arbor: Health Administration Press; 2005.
- [3] Watson J. Nursing: The philosophy and science of caring. 2nd ed. Boulder: University Press of Colorado; 2008.
- [4] Husserl E. Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Gaos J, traductor. México D.F.: Fondo de Cultura Económica; 1949.
- [5] Creswell JW. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. 3rd ed. Thousand Oaks (CA): SAGE Publications; 2013.
- [6] van Manen M. Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy. Albany (NY): State University of New York Press; 1990.
- [7] Moustakas C. Phenomenological research methods. Thousand Oaks (CA): SAGE Publications; 1994.
- [8] Norlyk A, Harder I. What makes a phenomenological study phenomenological? An analysis of peer-reviewed empirical nursing studies. Qual Health Res. 2010;20(3):420-31.
- [9] Benner P. From novice to expert: Excellence and power in clinical nursing practice. Commemorative ed. Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall; 2008.
- [10] Wilson HS. Research in nursing. 3rd ed. Redwood City (CA): Addison-Wesley; 2007.
- [11] Esbensen BA, Swane CE, Hallberg IR, Thome B. Being a next of kin to an elderly person with cancer: Experiences of the relationship to the person with cancer and to the health care system. Eur J Oncol Nurs. 2008;12(1):40-8.
- [12] Lincoln YS, Guba EG. Naturalistic Inquiry. Beverly Hills (CA): SAGE Publications; 1985.
- [13] Quintana L, Hermida J. La hermenéutica como método de interpretación de textos en la investigación psicoanalítica. Rev Psicolog Cienc Afines. 2019;16(2):73-80.
- [14] Montes-Sosa G, Castillo-Sanguino N. El método fenomenológico en la investigación educativa. Diálogos sobre educ. 2024;15(29):1-15.
- [15] Cotán Fernández A. El método etnográfico como construcción de conocimiento. MÁRGENES. 2020;1(1):83-103.

-
- [16] Okuda Benavides M, Gómez-Restrepo C. Métodos en investigación cualitativa: triangulación. *Rev Colomb Psiquiatr.* 2005;34(1):118-24.
- [17] Ministerio de Salud del Perú. Política Nacional de Calidad en Salud. Lima: MINSA; 2021.
- [18] Pineda EB, De Alvarado EL, De Canales FH. Metodología de la investigación: manual para el desarrollo de personal de salud. 2da ed. Washington D.C.: OPS/OMS; 1994.
- [19] Katayama Omura RJ. Introducción a la investigación cualitativa: fundamentos, métodos, estrategias y técnicas. Lima: Fondo Editorial UIGV; 2014.
- [20] Ministerio de Salud del Perú. Líneas de Investigación en Salud al 2030: Resolución Ministerial N° 424-2025/MINSA. Lima: MINSA; 2025.
- [21] Dirección Regional de Salud de Ayacucho. Prioridades Regionales de Investigación en Salud de Ayacucho 2025–2030. Ayacucho: DIRESA; 2025.
- [22] Aguirre-Andrade M, Tenorio-Acosta I, Rivas-Díaz L, Valenzuela-Oré F, Sánchez-Simbrón M, Quino-Huamaní F. Promoción de salud y nivel de salubridad de las familias, en comunidades del Distrito de Cangallo, Ayacucho 2020. *Rev Investig Salud.* 2020;14(2):45-58.
- [23] Asociación Médica Mundial. Declaración de Helsinki de la AMM: Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Ferney-Voltaire: WMA; 2013.
- [24] Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS). Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos. Ginebra: CIOMS; 2016.

ANEXOS

ANEXO 1: GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD SEMIESTRUCTURADA

Título: Percepción de la calidad de atención en usuarios del Centro de Salud Belén, Ayacucho 2026.

Objetivo: Recoger la experiencia vivencial del usuario sobre la atención recibida en el Centro de Salud Belén.

I. Preguntas de Apertura y Clima de Confianza:

1. ¿Podría relatarme qué le motivó a acudir el día de hoy al Centro de Salud Belén?
2. ¿Con qué frecuencia asiste a este establecimiento y qué servicios o áreas suele visitar habitualmente?

II. Preguntas por Dimensiones y Categorías Temáticas:

II. Preguntas por Dimensiones y Categorías Temáticas:

- Dimensión 1: Acceso, disponibilidad de cupos y madrugadas (Existencial: Temporalidad)

3. ¿A qué hora tuvo que salir de su casa y hacer fila para conseguir un cupo o turno de atención? ¿Qué vivencias, frío y dificultades atravesó mientras esperaba de madrugada?

- Dimensión 2: Emociones, cansancio y sentires afectivos (Existencial: Corporalidad y Afecto)

4. ¿Cuáles son los sentimientos o emociones (tranquilidad, alivio, tristeza, enojo, impotencia, cansancio físico o dolor) que experimentó su cuerpo a lo largo de las horas de espera hasta ingresar a la consulta?

- Dimensión 3: Afrontamiento y respuesta vivencial ante trabas o desabastecimiento

5. Si en farmacia no tuvieron todas las medicinas que le recetaron o si el médico demoró en atenderle, ¿cómo reaccionó usted? ¿Tuvo que gastar su propio dinero en boticas particulares?

- Dimensión 4: Formas de interacción, trato humano y empatía (Existencial: Relacionalidad / Encuentro Interpersonal)

6. ¿Cómo describe el trato que recibió por parte del médico, de la enfermera y de admisión? ¿Le miraron a los ojos, le escucharon con paciencia? ¿Le hablaron en quechua cuando lo necesitó?

• Dimensión 5: Claridad comunicativa, entorno físico y privacidad (Existencial: Espacialidad)

7. ¿Le explicaron con calma cómo debe tomar sus medicamentos y entendió claramente las indicaciones? ¿Se sintió cómodo en la sala y respetaron su intimidad dentro del consultorio?

• Dimensión 6: Significado holístico de la calidad y esencia de la experiencia (Esencia del Fenómeno)

8. Al reflexionar sobre toda su vivencia de hoy, ¿qué significa para usted que le brinden una atención de verdadera calidad y qué propondría para humanizar el Centro de Salud Belén?

ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA FENOMENOLÓGICA CUALITATIVA

TÍTULO: PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD BELÉN, AYACUCHO 2026.

PROBLEMA FENOMENOLÓGICO	OBJETIVOS	PREGUNTAS NORTEADORAS	CATEGORÍAS DE ESTUDIO	METODOLOGÍA FENOMENOLÓGICA
General: ¿Cuál es el significado, estructura y esencia de la experiencia vivida por los usuarios respecto al fenómeno del acceso y la calidad de atención en el C.S. Belén, Ayacucho 2026? Específicos: 1. Develar emociones y vivencias corporales. 2. Describir la temporalidad en la madrugada y espera. 3. Identificar la espacialidad y afrontamiento. 4. Caracterizar la relacionalidad e interculturalidad. 5. Interpretar la esencia de la calidad asistencial.	General: Comprender la estructura y esencia de la experiencia vivida por los usuarios respecto al acceso y la calidad de atención en el C.S. Belén, Ayacucho 2026. Específicos: 1. Develar las emociones, sentimientos y vivencias corporales. 2. Describir la temporalidad vivida en la trayectoria asistencial. 3. Identificar la espacialidad del	1. Corporalidad y emociones en la atención. 2. Temporalidad en la madrugada y espera. 3. Espacialidad y mecanismos de afrontamiento. 4. Relacionalidad y trato intercultural quechua. 5. Esencia compartida de calidad asistencial.	Categoría 1: Acceso a Servicios de Salud • Disponibilidad de cupos • Acomodación (Temporalidad) • Asequibilidad y gasto SIS • Aceptabilidad quechua (Relacionalidad) Categoría 2: Calidad Percibida • Trato empático (Relacionalidad) • Claridad pedagógica • Confort y privacidad (Espacialidad) • Esencia y confianza	Enfoque y Diseño: Cualitativo con diseño fenomenológico empírico y hermenéutico (Husserl, van Manen, Creswell, Sampieri). Existenciales: Temporalidad, espacialidad, corporalidad y relacionalidad. Población/Muestra: Usuarios de consulta externa del C.S. Belén. Muestreo intencional regulado por saturación teórica (12-18 participantes). Técnicas: Entrevista fenomenológica en profundidad y observación reflexiva.

	centro y afrontamiento. 4. Caracterizar la relacionalidad y trato en quechua/español . 5. Interpretar la esencia compartida y categorías divergentes.		institucional	Instrumentos: Guía semiestructurada bilingüe y diario de campo reflexivo.
--	---	--	---------------	--

ANEXO 3: FORMATO DE JUICIO DE EXPERTOS

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. Apellidos y nombres del informante (Experto):

1.2. Grado académico del experto:

1.3. Profesión del experto:

1.4. Institución donde labora:

1.5. Cargo que desempeña:

1.6. Denominación del instrumento: Guía de entrevista a profundidad semiestructurada.

1.7. Autor del instrumento: Gresly Lucero Pariona Palomino.

1.8. Título de la tesis: Percepción de la calidad de atención en usuarios del Centro de Salud Belén, Ayacucho 2026.

II. CRITERIOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES DE EVALUACIÓN	SÍ	NO	OBSERVACIONES
1. CLARIDAD DIALÓGICA	Preguntas formuladas con lenguaje coloquial, abierto y comprensible para el usuario andino.			
2. PERTINENCIA LINGÜÍSTICA	Preguntas en quechua chanka gramaticalmente naturales, afectuosas y culturalmente pertinentes.			

3. CONSISTENCIA FENOMENOLÓGICA	Articulación rigurosa con los cuatro existenciales del mundo de la vida (van Manen y Sampieri).			
4. COHERENCIA VIVENCIAL	Correspondencia simétrica entre las preguntas y la captura de la esencia y las divergencias vivenciales.			
5. RELEVANCIA DEL CUIDADO	Explora estrictamente la interacción humana, los sentires corporales y la dignidad del cuidado.			
6. CAPACIDAD DE SATURACIÓN	Capacidad inductora de las preguntas para suscitar relatos densos y alcanzar la saturación teórica.			

Observaciones

generales:

Ayacucho, ____ de ____ del 2026.

FIRMA Y SELLO DEL EXPERTO

ANEXO 4: MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, _____,
identificado con DNI N° _____, domiciliado en _____,
Distrito de _____,
Ayacucho, Región Ayacucho.

He tomado conocimiento del estudio de investigación titulado: “PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD BELÉN, AYACUCHO 2026”.

Declaro participar en calidad de Informante clave y me comprometo a brindar información fidedigna. Se me ha informado que la entrevista será grabada únicamente en audio, que mi participación es totalmente voluntaria, anónima y confidencial, y que puedo retirarme del estudio en el momento que considere conveniente sin que esto afecte mi atención en el centro de salud.

Para dar conformidad a este acto, firmo e imprimo mi huella digital al pie del documento.

Lugar y fecha: Ayacucho, ____ de ____ de 2026.

	[	]
FIRMA DEL PARTICIPANTE		HUELLA DIGITAL

ANEXO 5: MODELO DE CARTA DE ASESORÍA

Ayacucho, _____ de enero del 2026.

Dr. Alejandro Yarlequé Mujica
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

ASUNTO: Asunto: Carta de Aceptación y Asesoría Formal de Proyecto de Tesis

Sirva la presente para saludarlo cordialmente y a la vez comunicarle la asesoría formal del Proyecto de Tesis cualitativo titulado: “PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD BELÉN, AYACUCHO 2026”, perteneciente a la estudiante Gresly Lucero Pariona Palomino, egresada de la Escuela Profesional de Enfermería.

En tal sentido, dicha asesoría comprenderá todas las etapas del proyecto y ejecución del trabajo de investigación, permitiendo la obtención del Título Profesional de Licenciada en Enfermería.

Atentamente,

Dr. Manglio Aguirre Andrade

Docente de la Facultad de Ciencias de la Salud - UNSCH
ORCID: 0000-0001-8234-567X | DNI N°: _____